

Ensaio Geral da Curadoria

Marcado pelo Fundador para sábado, 05/09/2026. Kit no papel, do primeiro ao último ato · produção intocada. Atualizado em 28/08 para a operação das ADR-100 a 105 — a versão anterior ensaiava a operação antiga, sem Supervisor. A primeira marcação (ADR-076, 22–23/08) não aconteceu; esta é a segunda.

O caso do ensaio

O assistido é interpretado por uma pessoa de confiança. Ela inventa a própria história e conta ao vivo — o Curador não pode conhecê-la de antemão. **Uma única âncora combinada antes:** dor crônica nas costas (coluna), há mais de um ano, já passou por pelo menos um médico. Todo o resto é dela.

Elenco e materiais

PAPEL	QUEM	MATERIAL NA MÃO
Curador	Caio	Ficha do Assistido (em branco) · 2× Formulário do Profissional (em branco) · Folha da Mesa · Guia da Primeira Rodada
Assistido	Pessoa de confiança	Nada — só a âncora do caso
Supervisor do processo (ADR-100, entrou em 28/08)	Segunda pessoa da equipe	Roteiro do Supervisor — faz o primeiro contato, diz o preço, e assiste calado à Consulta Inicial se o assistido autorizar (ADR-103)
Observador	Alguém que não trabalhe no ensaio	Diário de Observação · FORA da Consulta Inicial (ADR-104) — entra nos atos 3, 4 e 5
Dr. Henrique Sales	Ninguém — formulário já devolvido	Parte 1 deste documento (impressa)
Dra. Marta Bering	Alguém ao telefone	Parte 2 deste documento (só quem interpreta lê)
Dr. Paulo Neiva	Alguém ao telefone (pode ser a mesma pessoa)	Parte 3 deste documento (só quem interpreta lê)

Ordem — os cinco atos

- O primeiro contato** (ato novo — ADR-100) — o Supervisor liga, escuta, explica a Aliviar e diz o preço, com o Roteiro do Supervisor. **Não pergunta nada de saúde** e não anota história clínica. Termina combinando a Consulta Inicial.
- Ouvir até ela reconhecer** — a Consulta Inicial com a Ficha do Assistido, até a assinatura de reconhecimento dela. Conduz o **Curador** (ADR-102). O Supervisor assiste calado, **se ela autorizar quando perguntada** (ADR-103). O observador **não entra** (ADR-104).
- A declaração assinada do médico** — ler o formulário devolvido do Dr. Henrique; entrevistar a Dra. Marta e o Dr. Paulo ao telefone, preenchendo um Formulário em branco para cada um durante a conversa. Assinatura simulada ao fim. A ordem aqui diverge do passo 2 do Guia da Primeira Rodada ("os médicos antes do assistido") — no ensaio a entrevista cabe depois da Consulta. A regra que não se quebra é outra, e vale nos dois: **sem formulário assinado, ninguém entra na Mesa** (ato 4).

4. **Cruzar e escolher três com nome** — a Folha da Mesa, com os três formulários e a Ficha dela sobre a mesa.
5. **Apresentar — a decisão é dela** — devolver à pessoa que interpreta o assistido e registrar a decisão POR ELA na Folha.

As regras que não se quebram nem no ensaio

- Quem interpreta médico responde **só o que for perguntado** — se o roteiro não puxar, a informação não aparece, e essa lacuna é um achado do Diário.
- O que o personagem não sabe, transcreve-se como "**não informado**" — nunca se preenche por ele. Lacuna nunca é defeito.
- O Diário de Observação (no Guia) é preenchido **durante**, não de memória. Ele é o produto do ensaio. **Exceção única (ADR-105):** a Consulta Inicial se anota DEPOIS, ao sair — e quem anota é o **Supervisor**, só sobre o processo (tempo, travas, o que faltou), nunca sobre o que a pessoa disse.
- Nada entra no sistema. Se quiser ensaiar a ata de transcrição depois, só no ambiente local.
- **Depois da Consulta Inicial, pergunte a quem interpretou o assistido:** *"o que você teria dito se estivesse sozinha com o Curador?"* Com o observador fora da sala (ADR-104), esta é a ÚNICA leitura possível do risco que a ADR-103 aceitou sem medir — e ela só existe porque isto é ensaio. Um assistido real nunca diria.

Parte 1 — Formulário devolvido

Dr. Henrique Sales (fictício) · Ortopedia e Traumatologia — coluna · CRM 00000-ENSAIO · preenchido e assinado em 20/08/2026 (simulado)

COMO USAR

Este formulário chega PRONTO ao Curador — ninguém o interpreta. O exercício é o da leitura: transcrever para a Folha da Mesa o que está declarado, e anotar no Diário o que você sentiu falta de perguntar.

Acesso

Modalidade de atendimento

Em quais formatos você atende hoje?

- ☒ Híbrido, conforme o caso

DETALHE Primeira consulta sempre presencial; retornos podem ser remotos quando o quadro permite.

"Coluna eu preciso examinar. Depois que conheço a pessoa, o retorno pode ser por vídeo sem perda."

Disponibilidade

Em quais janelas você atende habitualmente?

- ☒ Manhã, dias úteis
- ☒ Tarde, dias úteis

Prazo para a primeira consulta

Qual o prazo habitual para a primeira consulta?

- ☒ De 8 a 15 dias

Local de atendimento

Em quais endereços você atende presencialmente?

TIPO DE LOCAL

- ☒ Consultório
- ☒ Hospital

Consultório próprio (bairro central) e Hospital Andorinhas — nomes fictícios do ensaio.

Viabilidade

Cobertura e convênio

Por quais formas de cobertura você atende hoje?

- ☒ Convênios selecionados
- ☒ Emite documentação para reembolso

DETALHE Convênios Azul Saúde e VidaPlena (fictícios).

Custo e pagamento

Qual o custo da primeira consulta e como pode ser pago?

FAIXA

- ☒ De R\$ 601 a R\$ 1.000

FORMAS

- ☒ Dinheiro ou Pix
- ☒ Cartão à vista

CUSTOS ADICIONAIS

- ☒ Exames não inclusos

Experiência

Tempo de prática

Há quanto tempo atua na especialidade?

- ☒ De 11 a 20 anos

Volume de atuação

Com que frequência atende esse tipo de caso?

- ☒ Semanalmente

Experiência no tipo de caso

Com quais condições e procedimentos você tem prática regular?

Dor crônica de coluna é o centro da prática há 12 anos; cerca de 40 casos novos por ano, a maioria tratada sem cirurgia.

"A maioria das colunas que eu vejo não precisa de bisturi. Precisa de diagnóstico certo e de alguém que acompanhe."

Limites de atuação

Quais situações você não atende e encaminha?

ENCAMINHAMENTO

- ☒ Encaminha com indicação

Não opera deformidades complexas (escoliose grave do adulto); nesses casos encaminha nominalmente a um colega de centro de referência.

Formação

Graduação

Instituição e ano de graduação

Medicina — Faculdade Serra Verde (fictícia), 2004.

Residência médica

Residências concluídas

Ortopedia e Traumatologia — Hospital Andorinhas (fictício), 2005–2008.

Especialização

Títulos de especialista

Cirurgia de Coluna — título de especialista (sociedade fictícia do ensaio), 2010.

Fellowship

Fellowships realizados

Não realizou.

Formação complementar

Outras formações relevantes

Curso de dor crônica musculoesquelética (40h, 2019).

Histórico

Trajectoria institucional

Vínculos institucionais atuais e anteriores

12 anos como assistente da equipe de coluna do Hospital Andorinhas (fictício); consultório próprio desde 2016.

Atividade acadêmica

Atividade acadêmica

- ☒ Leciona

Áreas de atuação

Áreas em que atua hoje

Coluna degenerativa; dor crônica de coluna; hérnia de disco.

Modelo de atendimento

Como explica

Ao explicar um diagnóstico ou tratamento, quais dessas ações você costuma realizar?

- ☒ Adapta a linguagem ao interlocutor
- ☒ Verifica se a pessoa compreendeu
- ☒ Envia resumo escrito
- ☒ Reserva tempo para perguntas

"Se a pessoa saiu do consultório sem saber explicar o que tem, a consulta falhou — foi minha, não dela."

Como conduz decisões

Quando existem duas ou mais opções clinicamente adequadas, quais ações você costuma realizar antes da decisão?

- ☒ Apresenta todas as opções adequadas
- ☒ Explica riscos e benefícios de cada uma
- ☒ Pergunta o que importa para a pessoa
- ☒ Oferece tempo para decidir

Participação de acompanhantes

Como você conduz a presença de acompanhantes?

- ☒ Acompanhante bem-vindo sempre
- ☒ Parte da consulta a sós

Explicação de alternativas

Ao propor uma conduta, quais dessas você costuma apresentar?

- ☒ Opções de tratamento disponíveis
- ☒ Opção de acompanhar sem intervir
- ☒ Riscos de cada caminho
- ☒ O que acontece se nada for feito

Respeito a recusas e restrições

Quando a pessoa recusa uma conduta ou tem restrição pessoal, religiosa ou cultural, o que você costuma fazer?

- ☒ Registra a restrição no prontuário
- ☒ Busca alternativa compatível
- ☒ Explica consequências e mantém o acompanhamento

Condução de notícias difíceis

Ao comunicar um diagnóstico grave ou uma notícia difícil, quais dessas condutas você costuma adotar?

- ☒ Reserva tempo dedicado para a conversa
- ☒ Pergunta o quanto a pessoa quer saber
- ☒ Comunica junto com os próximos passos

Continuidade do cuidado

Retornos

Após a primeira consulta, quais dessas condutas você costuma adotar?

- ☒ Retorno programado na própria consulta
- ☒ Retorno conforme a evolução

FREQUENCIA HABITUAL

- ☒ De 1 a 3 meses

Acompanhamento pós-procedimento

Após um procedimento que você realiza, quais condutas são habituais?

- ☒ Acompanha com equipe

DURACAO HABITUAL

- ☒ Até 6 meses

Equipe de apoio

Quem mais acompanha as pessoas que você atende?

- ☒ Enfermagem

- ☒ Secretaria clínica
- ☒ Fisioterapia

Coordenação com outros profissionais

Quando a pessoa já é acompanhada por outros profissionais, o que você costuma fazer?

- ☒ Envia relatório escrito
- ☒ Contata diretamente o outro profissional

Canais entre consultas

Entre uma consulta e outra, como a pessoa consegue contato?

- ☒ Mensagem com a equipe ou secretaria

PRAZO DE RESPOSTA

- ☒ Até 48h

Termo de Veracidade e Autorização

Declaro que as informações acima são verdadeiras e autorizo seu uso na Rede Aliviar, nos termos do Formulário do Profissional.

Henrique Sales — assinatura simulada para o ensaio

20/08/2026

Parte 2 — Ficha de personagem

Dra. Marta Bering (fictício) · Ortopedia — coluna (fisiatria do aparelho locomotor) · CRM 00000-ENSAIO (fictício)

SÓ QUEM INTERPRETA LÊ ESTA FICHA

Perfil MÉDIO — competente, direta e seca. Ensina o Curador a puxar detalhe. O Curador entrevista ao telefone com o Formulário do Profissional em branco na mão — e transcreve durante a conversa.

Como você fala

- Responde curto e só o que foi perguntado. Nunca oferece informação extra.
- Se a pergunta vier vaga, devolve: "como assim?".
- Não é hostil — é objetiva. Se o Curador pedir exemplo, dá um, bom.
- Tem opinião firme: acha que médico que apresenta dez opções confunde o paciente.

O que você responde, por tema

Não leia em voz de leitura — responda com naturalidade, nas suas palavras. Os parênteses são instruções, não falas. Detalhes que faltarem, invente coerente com o personagem.

Acesso

"Atendo no consultório, presencial. Online eu não faço — coluna se examina com a mão."

"Terça a sexta, à tarde. Primeira consulta costuma sair em umas três, quatro semanas."

(Se perguntarem o local:) "Consultório na Clínica Horizonte (fictícia). Só lá."

Viabilidade

"Particular. Não trabalho com convênio." (Se insistirem em reembolso:) "Recibo eu dou; relatório para reembolso, não emito."

"A consulta fica entre trezentos e seiscentos. Pix ou cartão à vista."

(Custos extras — só se perguntarem:) "Retorno depois de 30 dias é cobrado como consulta nova."

Experiência

"Oito anos de prática. Dor de coluna eu vejo todo mês, é boa parte do consultório."

"Não opero. Meu trabalho é tratamento conservador; quando é caso cirúrgico, encaminho e digo para quem."

Formação

"Medicina na Federal daqui (fictícia), residência em Medicina Física e Reabilitação, título em 2018."

(Fellowship, cursos:) "Fellowship não. Curso de bloqueio e infiltração, 2021."

Histórico

"Passei quatro anos no ambulatório de dor do serviço público; desde 2020 só consultório."

"Atividade acadêmica, nenhuma. Não é o meu interesse."

Modelo de atendimento

"Eu examino, explico o que a pessoa tem e digo o que eu faria. Explico o porquê. Quem decide é ela, mas ela veio ouvir a minha opinião — dar uma lista de opções sem opinião é empurrar a decisão de volta."

"Acompanhante entra se a paciente quiser. Uma parte da consulta eu faço a sós com ela."

(Restrições da paciente:) "Anoto e procuro caminho compatível. Se não existir, explico o que se perde e sigo acompanhando."

(Notícias difíceis:) "Falo com calma e já com o plano do que fazer. Rodeio não ajuda ninguém."

Continuidade do cuidado

"Retorno quando o quadro pede — quem marca é a paciente quando sente necessidade. Eu não fico ligando."

"Equipe fixa não tenho; a secretária resolve agenda. Entre consultas, o canal é remarcar."

(Coordenação com outro médico:) "Mando relatório escrito quando encaminho. Discussão de caso, se o colega ligar, atendo."

Ao final

Se o Curador pedir, você "assina" o formulário que ele preencheu: ele escreve seu nome com a nota *assinatura simulada para o ensaio*. Antes disso, ele deve LER de volta o que transcreveu — se ele não ler, anote: essa releitura é parte do método e a falta dela é achado do Diário.

Parte 3 — Ficha de personagem

Dr. Paulo Neiva (fictício) · Ortopedia e Traumatologia — coluna · CRM 00000-ENSAIO (fictício)

SÓ QUEM INTERPRETA LÊ ESTA FICHA

Perfil com LACUNAS HONESTAS — recém-chegado à cidade, agenda aberta, muita coisa ainda por definir. Testa a régua: lacuna nunca é defeito. O Curador entrevista ao telefone com o Formulário do Profissional em branco na mão — e transcreve durante a conversa.

Como você fala

- Fala bastante e em volta — conta um caso antes de responder. O Curador precisa trazer de volta à pergunta.
- É genuinamente honesto: quando não sabe, diz "ainda não sei te dizer" — e isso deve ser transcrito como está, nunca inventado.
- Simpático, escuta bem, agradece a pergunta.
- Se o Curador aceitar a resposta vaga e seguir adiante, deixa passar — o erro fica no papel.

O que você responde, por tema

Não leia em voz de leitura — responda com naturalidade, nas suas palavras. Os parênteses são instruções, não falas. Detalhes que faltarem, invente coerente com o personagem.

Acesso

"Cheguei na cidade há três meses, estou montando o consultório. A agenda está aberta — semana que vem eu tenho horário, de verdade."

"Presencial com certeza; vídeo eu quero oferecer, mas ainda estou organizando. Te digo que hoje é presencial."

(Local:) "Estou numa sala alugada na Clínica Miradouro (fictícia) enquanto o consultório não fica pronto."

Viabilidade

"Convênio estou credenciando dois, mas ainda não saiu — hoje, na prática, é particular. Isso deve mudar em uns dois meses, mas não posso prometer."

"O valor eu ainda estou fechando com a clínica... deve ficar perto de quatrocentos, mas me liga antes que eu confirme." (= sujeito a confirmação — transcrever assim.)

Experiência

"Formei há quatro anos. Na residência eu vivi coluna — plantão de porta, muita lombalgia. Consultório próprio com esse perfil de caso é mais recente, então volume eu ainda não tenho como te dar um número honesto."

"Cirurgia grande de coluna eu não faço sozinho — se aparecer, eu encaminho para o serviço onde me formei, com carta."

Formação

"Medicina na Universidade do Vale (fictícia), residência em Ortopedia no Hospital Regional Sul (fictício), terminei em 2024. Estou no segundo ano de uma especialização em coluna, em andamento — termino ano que vem."

Histórico

"Trajetória institucional é curta: residência e um ano de ambulatório no mesmo hospital. Publiquei um relato de caso na residência, se isso conta."

Modelo de atendimento

"Eu pergunto muito. Quero saber o que a pessoa já tentou, o que ela acha que tem, o que importa pra ela. Aprendi que metade do diagnóstico está aí."

"Opções eu apresento todas as que couberem, com calma, e dou tempo — ninguém decide bem no susto."

(Notícias difíceis:) "Vou ser honesto: nunca precisei conduzir uma notícia realmente grave sozinho. Na residência quem fazia era o chefe. Não sei te responder bem como eu faria." (= transcrever a honestidade, não preencher por ele.)

Continuidade do cuidado

"Retorno eu já deixo combinado na consulta, e entre consultas a pessoa me manda mensagem direto — por enquanto sou eu mesmo que respondo, no mesmo dia, porque a agenda deixa."

"Equipe ainda não tenho. É o próximo passo depois do consultório."

(Pós-procedimento:) "Procedimento eu não realizo por enquanto — então esse item, pra mim, hoje, não se aplica."

Ao final

Se o Curador pedir, você "assina" o formulário que ele preencheu: ele escreve seu nome com a nota *assinatura simulada para o ensaio*. Antes disso, ele deve LER de volta o que transcreveu — se ele não ler, anote: essa releitura é parte do método e a falta dela é achado do Diário.